



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

Vigilancia de Eventos Adversos posteriores a la
vacunación contra el COVID-19 en Ecuador
Periodo de reporte

Ministerio de Salud Pública

ARCSA Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria

DNVE Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

MSP Ministerio de Salud Pública

OPS Organización Panamericana de la Salud

Tabla de contenidos

1	Antecedentes	6
2	Desarrollo	7
3	Resumen Ejecutivo	8
4	Distribución geográfica de los casos reportados	9
5	Distribución ESAVI GRAVE por sexo	10
6	Distribución ESAVI GRAVE por tipo de vacuna	12
7	Distribución por grupo poblacional	13
8	Distribución por de ESAVI GRAVE por análisis de causalidad	15
9	Signos y síntomas con mayor número de reporte en los ESAVI NO GRAVES	16
10	Conclusiones	18
	Bibliografía	19

Lista de Figuras

4.1	Número total de casos ESAVI graves por provincia	9
9.1	ESAVI no grave por signos y síntomas	17

Lista de Tablas

1.1	Tasa de reporte de ESAVI no grave y grave en la Región de las Américas . . .	6
2.1	Número de dosis inoculadas	7
5.1	ESAVIs por sexo	11
6.1	Tasa de ESAVI grave por tipo de vacuna	12
7.1	Casos ESAVI por grupo etario	14
8.1	ESAVI GRAVE por análisis de causalidad	15
9.1	ESAVI no grave por signos y síntomas mayormente reportados	16

1 Antecedentes

El 31 de diciembre de 2019 se identificaron los primeros casos de neumonía de origen desconocido en China, y el 7 de enero de 2020 se conoció por primera vez un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en humanos [1]. El primer caso de esta enfermedad en Ecuador fue reportado el 29 de febrero de 2020 [2].

El 21 de enero de 2021 inició el proceso de vacunación en el Ecuador. Al momento, en el Ecuador se aplican las vacunas Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y la vacuna Cansino. Todas las vacunas fueron aprobadas por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ([ARCSA](#)) [2].

En la tabla se evidencia la tasa de reporte de ESAVI NO GRAVE Y ESAVI GRAVE en la Región de las Américas, las cuales son reportadas a la Organización Mundial de la Salud.

Tabla 1.1: Tasa de reporte de ESAVI no grave y grave en la Región de las Américas

Vacunas	Ecuador		Chile		Colombia		Canadá	
	G_Ec	NG_Ec	G_Ch	NG_Ch	G_C	NG_C	G_Cd	NG_Cd
Pfizer	6,8	36,8	122,8	36,2	0,0	29,2	46,2	NA
Sinovac	0,2	1,6	3,4	11,4	0,6	1,8	2,6	NA

2 Desarrollo

Entre el 21 enero de 2021 al 14 de noviembre del 2023, se han inoculado un total de 67 587 084 dosis, de las cuales, primeras dosis corresponden a 45 772 761, segundas dosis corresponde a 12 805 884, primer refuerzo corresponde a 6 700 453 dosis, segundo refuerzo corresponde a 2 307 986.

Por el tipo de biológico, con corte al 08-oct.-2024, el 10.66% de dosis administradas corresponde a la vacuna ASTRAZENECA, con un total 7 206 675 de dosis inoculadas, el 50% de dosis corresponde a la vacuna NA con un total de 33 793 542 de dosis inoculadas.

En la **Fig-vacunas** se muestran los porcentajes del tipo de vacunas inoculadas hasta el corte del presente informe.

Tabla 2.1: Número de dosis inoculadas

[H]

Vacuna	Dosis 1	Dosis 2	Refuerzo 1	Refuerzo 2	Total
NA	33,793,542 (73.8%)	NA (-)	NA (-)	NA (-)	33,793,542 (50.0%)
PFIZER	3,608,595 (7.9%)	3,663,201 (28.6%)	2,055,936 (30.7%)	344,699 (14.9%)	9,672,431 (14.3%)
CANSINO	NA (-)	486,028 (3.8%)	121,145 (1.8%)	45,617 (2.0%)	652,790 (1.0%)
ASTRAZENECA	1,298,977 (2.8%)	1,534,272 (12.0%)	3,709,860 (55.4%)	663,566 (28.8%)	7,206,675 (10.7%)
SINOVAC	7,071,647 (15.4%)	7,122,383 (55.6%)	813,512 (12.1%)	1,254,104 (54.3%)	16,261,646 (24.1%)
Total	45,772,761 (100.0%)	12,805,884 (100.0%)	6,700,453 (100.0%)	2,307,986 (100.0%)	67,587,084 (100.0%)

Fuente: Vacunómetro

Elaborado por: DNVE-DNI

3 Resumen Ejecutivo

Se han reportado un total de casos ESAVI graves y no graves, en un total de de dosis inoculadas. Se han reportado, 98 casos de ESAVI GRAVE en un total de las 36 525 038 de dosis inoculadas, una tasa de reporte de 0,26 casos por 100 000 dosis inoculadas. La tasa de reporte de ESAVI GRAVE para el sexo masculino corresponde a 0,14 casos por 100 000 dosis inoculadas. La tasa de reporte de ESAVI GRAVE para el sexo femenino corresponde a 0,14 casos por 100 000 dosis inoculadas. La tasa de reporte de ESAVI GRAVE para la vacuna Pfizer es 0,14 casos por 100 000 dosis inoculadas, para la vacuna Sinovac corresponde a 0,07 casos por 100 000 dosis inoculadas, para la vacuna AstraZeneca corresponde a 0,07 casos por 100 000 dosis inoculadas, para la vacuna Cansino corresponde a 0,003 casos por 100 000 dosis inoculadas y no reporta la vacuna que corresponde a 0,01 casos por 100 000 dosis inoculadas. En relación con la distribución de notificaciones de ESAVI GRAVE por grupo poblacional, el grupo poblacional con más reporte de ESAVI GRAVE es el grupo poblacional comprendido entre los 25 hasta los 49 años, con una tasa de ESAVI GRAVE de 0,12 casos por 100 000 dosis inoculadas. La provincia de Pichincha reporta el mayor número de ESAVI GRAVES con un total de 41 casos reportados.

Los ESAVI GRAVES, son notificados y dados seguimiento por vigilancia, a partir de lo cual la comisión nacional de ESAVI determinará la relación causal y notificará si corresponde a un ESAVI GRAVE. Al momento se ha realizado el análisis de causalidad de 42 casos que corresponde al 42,85%.

4 Distribución geográfica de los casos reportados

En el Ecuador desde el inicio de la vacunación hasta el 25 de julio del 2022, se han reportado 98 ESAVI GRAVE. La provincia de Pichincha reportó 41 casos, la provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas reportó 12 casos, la provincia de Manabí reportó 8 casos, la provincia de Azuay reportó 7 casos, la provincia de Tungurahua reportó 6 casos, la provincia del Oro reportó 5 casos, la provincia de Bolívar reportó 3 casos, la provincia de Esmeraldas reportó 3 casos, la provincia de Guayas reportó 3 casos, la provincia de los Ríos reportó 3 casos, la provincia de Chimborazo reportó 2 casos, la provincia de Sucumbíos reportó 2 casos, la provincia de Imbabura reportó 1 caso, la provincia de Loja reportó 1 caso y la provincia de Napo reportó 1 caso.

En la Figura 4.1 se muestra el mapa con el número de casos.

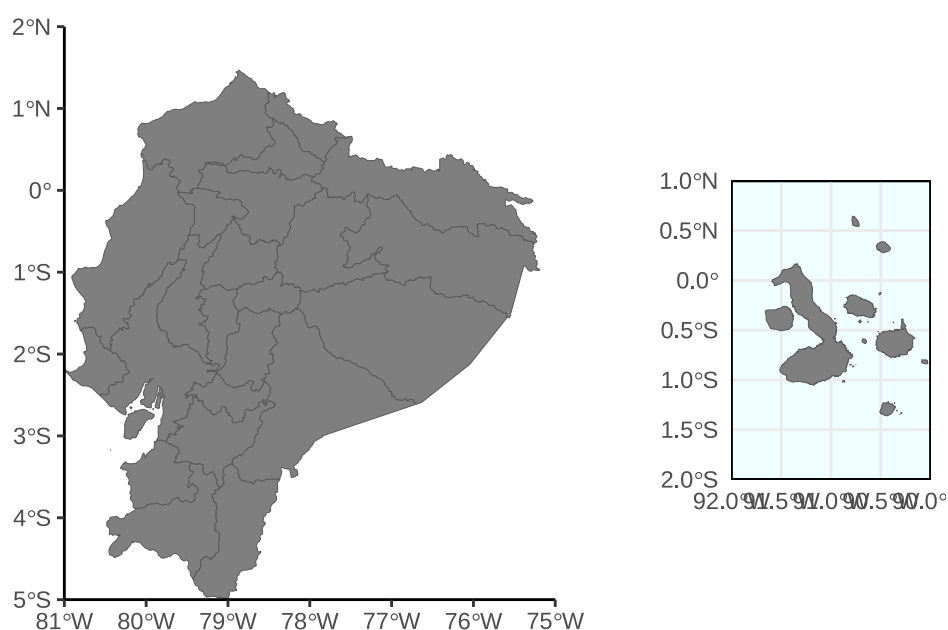


Figura 4.1: Número total de casos ESAVI graves por provincia

5 Distribución ESAVI GRAVE por sexo

En el periodo desde el 21 de enero del 2021 al 23 de marzo de 2023. Los ESAVI GRAVES según sexo, al masculino le corresponde el **49% (48 casos)** (Tabla [5.1](#)) con una tasa de reporte de 0,14 casos por 100 000 dosis inoculadas; al femenino le corresponde el **51% (50 casos)** con una tasa de reporte de 0,14 casos por 100 000 dosis inoculadas.

Tabla 5.1: ESAVIs por sexo

[H]			
	Año	Sexo	Número de casos
	2020	MUJER	2
	2021	DESCONOCIDO	6
	2021	HOMBRE	1787
	2021	MUJER	4000
	2022	HOMBRE	88
	2022	MUJER	121
	2023	HOMBRE	29
	2023	MUJER	54
	NA	DESCONOCIDO	3
	NA	HOMBRE	291
	NA	MUJER	454

6 Distribución ESAVI GRAVE por tipo de vacuna

En el periodo desde el 21 enero del 2021 al 25 de julio del 2022, la vacuna con mayor número de ESAVI GRAVES corresponde a la vacuna Pfizer con el 50% (49 casos) (tasa de reporte de 0.14 casos por 100.000 dosis inoculadas), la vacuna AstraZeneca con el 24% (23 casos) (tasa de reporte de 0,07 casos por 100 000 dosis inoculadas), la vacuna Sinovac con el 23% (23 casos) (tasa de reporte de 0.07 casos por 100.000 dosis inoculadas), la vacuna Cansino con el 1 % (1 caso) (tasa de reporte de 0.003 casos por 100.000 dosis inoculadas) y 2 casos no reporta la vacuna que representa el 2 % (tasa de reporte de 0.01 casos por 100.000 dosis inoculadas).

Tabla 6.1: Tasa de ESAVI grave por tipo de vacuna

[H]

Vacuna	Tasa ESAVI graves
NA	338
PFIZER	97
CANSINO	7
ASTRAZENECA	72
SINOVAC	163

Fuente: Ministerio de Salud Pública. SIVE ALERTA

Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunizaciones

7 Distribución por grupo poblacional

En el periodo desde el 21 enero del 2021 al 25 de julio de 2022. En relación con la distribución de notificaciones de ESAVI GRAVE por grupo poblacional, el grupo poblacional con más reporte de ESAVI GRAVE es el grupo poblacional comprendido entre los 25 hasta los 49 años, con una tasa de ESAVI GRAVE de 0.12 casos por 100.000 dosis inoculadas.

Tabla 7.1: Casos ESAVI por grupo etario

[H]

Grupo etario	Casos
De 3 a 4 años	5
De 5 a 11 años	3
De 12 a 17 años	19
De 18 a 24 años	8
De 25 a 49 años	103
De 50 a 59 años	25
De 60 a 69 años	19
De 70 a 79 años	10
De 80 y mas	12
No registra la edad	63

8 Distribución por de ESAVI GRAVE por análisis de causalidad

En el periodo desde el 01 de octubre del 2021 al 25 de julio del 2022, se ha realizado el análisis de causalidad de 42 eventos que corresponde al 42,85% de los casos reportados como ESAVI GRAVE, 5 eventos fueron clasificados por relación causal con la vacuna ninguno terminó en fallecimiento.

Tabla 8.1: ESAVI GRAVE por análisis de causalidad

[H]	
Causa	Casos

9 Signos y síntomas con mayor número de reporte en los ESAVI NO GRAVES

En el periodo desde el 21 enero del 2021 al 25 de julio de 2022, se ha notificado 3 635 ESAVI NO GRAVES, de los cuales el 67,93% corresponde a la vacuna Pfizer (tasa de reporte de 6,81 casos por 100.000 dosis inoculadas), el 26,17% corresponde a la vacuna AstraZeneca (tasa de reporte de 2,54 casos por 100.000 dosis inoculadas), el 5,71 % corresponde a la vacuna Sinovac (tasa de reporte de 0,58 casos por 100.000 dosis inoculadas).

En el período comprendido del 01 de enero del 2022 al 07 de mayo del 2022, Los signos y síntomas que se presentan en los casos que se reportan como ESAVI NO GRAVE con mayor frecuencia son fiebre, cefalea, malestar general, dolor en el sitio de la punción, mialgia, artralgia, náusea, diarrea, escalofrío, vómito.

Tabla 9.1: ESAVI no grave por signos y síntomas mayormente reportados

[H]

Signo/Síntoma	Casos
---------------	-------

Fuente: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)

Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunizaciones

Frecuencia

Figura 9.1: ESAVI no grave por signos y síntomas

10 Conclusiones

1. Las tasas reportadas de los ESAVI GRAVES, están dentro lo esperable, son similares en otros países de la región y corresponde al reporte de la región de las Américas. El reporte de los ESAVI está dentro de los parámetros, en otros lugares de las Américas no hay señales de alarma con respecto a la seguridad de las vacunas.
2. La tasa de reporte de ESAVI GRAVE por tipo de vacuna es similar en los cuatro grupos, encontrándose dentro del rango de la ficha técnica del fabricante.
3. prueba

Bibliografía

- [1] SALUD, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA: *Marco de valores del SAGE de laOMS para la asignación y priorización de la vacunación contrala COVID-19* : OMS, 2014
- [2] [Se registra el primer caso de coronavirus en Ecuador – Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.](#)